

PATOLOGÍA TRAUMÁTICA DEL OÍDO

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

BLAST AURICULAR

Introducción

Traumatismo auricular por onda expansiva (blast) se debe a un aumento repentino de la presión en el conducto auditivo externo (CAE). Son lesiones traumáticas sobre el oído medio por cambios **súbitos** de presión. Estallido de materiales explosivos hasta una bofetada, pasando por impactos de objetos (bolas de nieve, balones).

Diagnóstico

¡Historia clínica! Exploración variable, desde otoscopia normal, hemotímpano hasta perforaciones timpánicas irregulares con puntos hemorrágicos; puede haber daño de la cadena osicular y mareo.

Tratamiento En Urgencias

Analgesia y AINES.

Gotas óticas si perforación.

Seguimiento por ORL.

BAROTRAUMA

Introducción

Alteraciones del oído medio por cambios **progresivos** de presión no compensados por trompa de Eustaquio (viajes aéreos, submarinismo o descensos rápidos de puertos y montañas).

Diagnóstico

Sensación de plenitud ótica, otalgia intensa, acúfenos, autofonía e hipoacusia de transmisión. Otoscopia: desde normal hasta perforación timpánica.

Tratamiento

Analgesia y AINES.

Pauta corta de corticoides orales.

Seguimiento por ORL.

FRACTURAS DE HUESO TEMPORAL

Introducción

Lesiones causadas en contexto de TCE.

Diagnóstico

¡Primero descartar patología neuroquirúrgica con prueba de imagen! TAC Craneal.

Otoscopia: hemotímpano o perforación. Las de trazo transversales pueden presentar vértigo o cofosis y parálisis facial; las longitudinales (más frecuentes) suele cursar con otorragia. La mayoría son mixtas.

Tratamiento En Urgencias

Valoración por ORL